

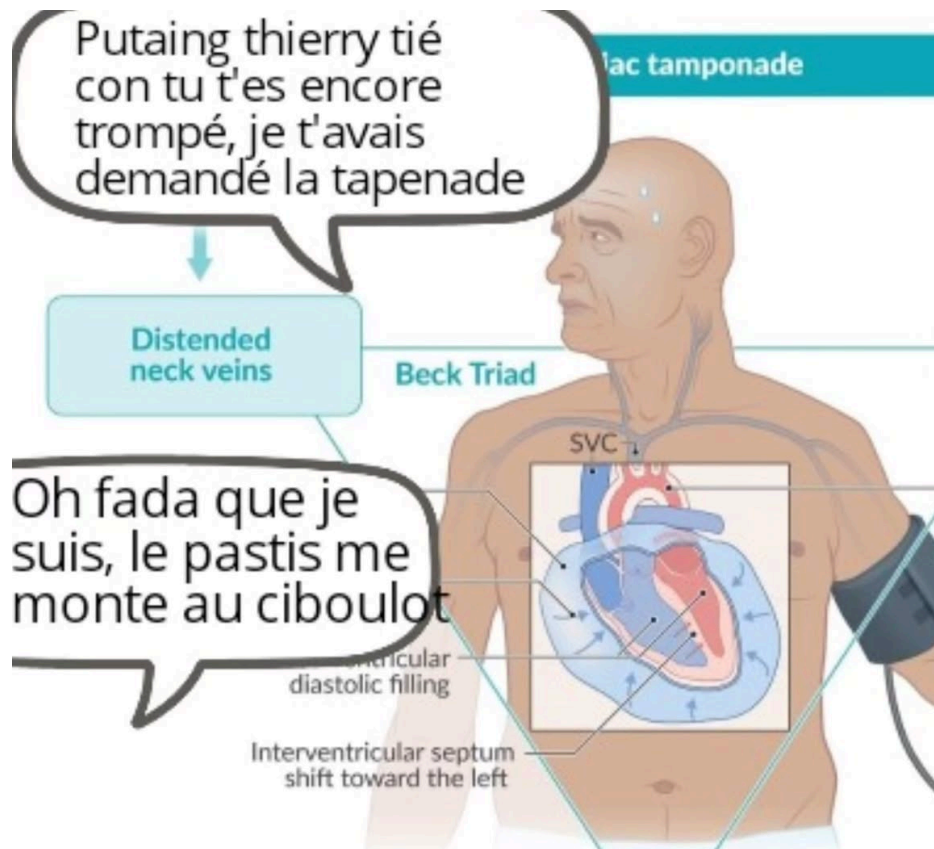
Examen fédéral 2025 - J1

VD-GE-FR : Vive la Romandie, et surtout le Valais Libre!

Biiiiig retranscrit du jour 1 avec les 120 questions retranscrites !

- 104 questions de type A
- 6 questions de type K'
- 2 questions de type menu déroulant
- 3 questions de type suivies

Merci aux anonymes !



Q1: [Question complète]

Jeune femme de 27 ans, qui ressent des douleurs abdominales apparues brusquement après le repas de midi. Son mari l'amène aux urgences car elle devient très pâle et son état général est diminué. Elle a été traitée pour une annexite il y a 3 ans. Dernières règles il y a 7 semaines. Au toucher rectal il y a un voussure sensible et du liquide dans le cul de sac de douglas. Présence de saignement vaginal Paramètre vitaux 86/65, 110 bpm.

- A. Torsion ovarienne
- B. GEU
- C. Appendicite
- D. Diverticulite
- E. Kyste Jaune

Réponse: GEU [Sûre]

Q2: [Question incomplète]

Patiente de 70 ans amenée par son mari dans une unité psychiatrique qui dit que sa femme a des pertes de mémoire depuis 1 ans, elle n'arrive pss à faire marcher la nouvelle machine à laver. A l'anamnèse la patiente ne rapporte pas hallucinations , l'examen clinique ne révèle pas de symptômes extrapyramidaux. Elle est cohérente et collaborante lors de l'entretien et à 21/30 au MMSE. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Démence Alzheimer
- B. Démence à corps de lewy
- C. Démence vasculaire
- D. Démence froto-temporal
- E. Huntington

Réponse: A [Sûre]

Q3: [Question complète] (ANCRAGE)

Une femme de 66 ans atteinte d'un carcinome mammaire métastasé depuis plusieurs années est hospitalisée en raison de l'apparition récente d'une carcinose péritonéale. Depuis quelques jours, sa tension artérielle est très basse et elle souffre d'une défaillance rénale aiguë. Vu son état général et le niveau bas de sa tension artérielle, les néphrologues ne voient aucune possibilité de la dialyser. Ses proches insistent pour qu'elle soit soumise à une dialyse, à défaut de quoi ils engageront des démarches juridiques. La patiente se rallie à leur exigence. Quelle est la manière la plus appropriée d'apprécier la situation?

- A. Tout patient a le droit d'être traité par dialyse quel que soit son état.
- B. La volonté du patient de subir une dialyse l'emporte sur l'appréciation des médecins. Il convient donc de pratiquer une dialyse.
- C. Vu que les proches sont aussi favorables au traitement par dialyse et qu'ils menacent d'engager des démarches juridiques, ce dernier doit être effectué.
- D. Le fait que d'un point de vue médical, le traitement par dialyse ne soit pas indiqué (futility) l'emporte sur le souhait des proches et de la patiente.
- E. En pareille situation, il y a lieu de faire appel à des autorités juridiques (autorité tutélaire, procureur).

Réponse: D [Sûre]

Q4: [Question complète]

Deux jeunes parents découvrent leur enfant de quelques mois inanimé dans le berceau. Sous le choc, ils vous demandent quelle précaution prendre pour éviter que ce même drame survienne au jumeau de l'enfant décédé. Quel élément met le jumeau à risque ?

- A. Sexe féminin
- B. Dormir avec une lolette
- C. Dormir dans une chambre entre 18 et 20 degrés
- D. Dormir sur le dos
- E. Ménage fumeur

Réponse: E [Sûre]

Q5: [Question incomplète]

Une patiente vivant en EMS présente depuis plusieurs mois, des vertiges et des troubles de la marche, elle fait notamment souvent des chutes. Pas d'autres signes cliniques relevés par les soignants hormis une incontinence urinaire connue. Un CT est réalisé :



Quel est le diagnostic ?

- A. Hématome épidural
- B. Hématome sous dural
- C. Hydrocéphalie
- D. Hématome sous-arachnoïdien
- E. Hématome intra-cérébral

Réponse: B [Sûre] → c'était pas évident sur le CT = hématome sous-dural chronique bilatéral fronto-temporal → hydrocéphalie chronique

Q6: [Question complète]

Patient de 45 ans se présentant aux urgences pour une douleur en FID, il est fébrile. Le CT permet de confirmer une appendicite aiguë. L'indication à une opération est posée. Quelle est l'utilité de la pré-oxygénation en anesthésie ?

- A. Éviter le risque d'atélectasie pulmonaire en post-opératoire
- B. Diminuer le temps d'intubation
- C. Permet une bronchodilatation
- D. Augmente le temps d'apnée possible
- E. Diminue les douleurs post-opératoires

Réponse: D [Sûre]

Q7: [Question incomplète]

Une fillette de 7 ans est amenée chez son pédiatre. Elle présente depuis 2 mois des céphalées, surtout le matin avec des vomissements associés. Ces céphalées sont pèjorées lorsqu'elle est couchée. L'examen clinique montre dysmétrie et troubles de la marche.

Quel examen complémentaire faire ?

- A. CT des sinus
- B. IRM cérébrale
- C. PL
- D. Rien

Réponse: B [Sûre] → suspicion de malformation d'Arnold Chiari ? Tumeur cérébelleuse avec hypertension intracrânienne ?

Q8: [Question complète]

Une mère appelle votre cabinet pour son enfant de 7 ans qui s'est brûlé en se renversant de l'eau chaude de la bouilloire pour le thé. Elle lui a rapidement enlevé son t-shirt et se prépare pour venir aux urgences. Vous lui expliquez la suite de la prise en charge la plus importante:

- A. Mettre un pansement sec et revenir consulté à une semaine au cabinet
- B. Mettre un pack de glace pendant 15 min puis aller consulter aux urgences
- C. Rincer pendant 15 min sous l'eau tiède puis aller consulter aux urgences
- D. Recouvrir la plaie et venir consulter au cabinet
- E. Mettre une crème antibiotique

Réponse C [Sûre] → pas la B car ça fait une vasoconstriction et pèjore

Q9: [Question complète, débattue]

Employé de banque de 37 ans, sans antécédents ni traitements, qui consulte son médecin généraliste le lundi matin après avoir déménagé pendant le week-end. Il se plaint de douleurs au dos, pas d'autres symptômes associés. 1m90, 79kg, BSH, pas de traitement habituel. Il est penché sur la gauche. Les muscles paravertébraux sont contractés et douloureux à la palpation au niveau lombaire. La distance doigts-sol est de 65cm. L'inclinaison lombaire est limitée aux 2/3 de la norme, le reste des mouvements sont limités au 1/3 de la norme. Les réflexes et l'examen neurologique des membres inférieurs sont normaux.

En plus d'un traitement antalgique adapté, quelle est la mesure indiquée en phase aiguë?

- A. Physiothérapie pour renforcer les muscles du dos
- B. Activité physique jusqu'aux limites de la douleur
- C. Repos au lit
- D. Mobilisation des articulations sacroiliaques
- E. Ceinture pelvienne (lombaire non ?)

Réponse: B +15+chatgpt (moi j'ai mis A +12 😊)(pour moi la physio c'est pas tt de suite; il a déménagé le we et lombalgies le lundi, donc je dirais d'abord AINS + bouger selon tolérance et si absence d'amélioration alors on ajoutera physio). Ah oui peut être, après je me dis qu'un peu de physiothérapie pour renforcer les muscles de son dos qui sont là probable cause d'une faiblesse qui favorise sa lombalgie c'était approprié 🧑 - B selon l'échelle de la fontaine

Q10: [Question complète]

Patiente de 72 ans qui vient pour un suivi dans votre cabinet. Elle prend depuis 5 jours 50 mg/j de prednisone pour une polymyalgia rheumatica. Elle n'a pas de plainte, les douleurs sont en amélioration. Au bilan biologique à jeun on a une glycémie à 12.5 mmol/L (3,9 - 6,1 mmol/l) et une Hb1Ac à 7.6% (4,8-5,9%).

Quelle est la cause la plus probable de ces valeurs?

- A. Diabète de type II
- B. Diabète cortico induit
- C. Intolérance au glucose
- D. Maladie de Cushing

Réponse: A [Sûre] → pas un diabète cortico-induit car HbA1c = reflet de la glycémie sur 2-3 mois. Yes et 5 jours une période courte pour un diabète cortico-induit

Q11: [Question complète]

Un homme de 58 ans, garde forestier, consulte son médecin de famille pour un érythème sur la face latérale de la cuisse gauche. L'érythème est apparu début juin et persiste depuis 6 semaines. Initialement, il s'agissait d'une petite tache rosée, qui s'est progressivement agrandie au cours des semaines, jusqu'à couvrir toute la cuisse. Le patient ne présente ni douleur, ni prurit, ni fièvre, est en bonne santé générale et ne prend aucun médicament. Quelle est la cause la plus probable de cet érythème ?

- A. Eczéma nummulaire
- B. Érythème migrant
- C. Panniculite
- D. Urticaire chronique
- E. Teigne



Réponse: B [Sûre] → l'image était un poil moins évidente avec la luminosité de merde de la tablette. +1 je voyais plus un hématome sur l'image haha

Q12: [Question complète, débattue]

Garçon de 10 ans non vacciné, amené par sa mère car rhinite et toux sèche depuis 1 semaine. Depuis 3 jours il a 39°C de fièvre et un rash sur le corps. Son état général est moyen et il présente une conjonctivite bilatérale non purulente. Il a des macules confluentes sur le corps, non prurigineuses et disparaissant à la vitropression. A l'examen clinique, on voit des papules blanchâtres sur fond érythémateux sur la muqueuse jugale. Le reste de l'examen est dans la norme.

Quel est le traitement adapté ?

- A. Acyclovir PO
- B. Amoxiciline PO
- C. Pommade ophtalmique de vit A
- D. Paracétamol PO
- E. Injection d'Immunoglobulines

Réponse: D +4, C +3 ? Pas Kawasaki car fièvre depuis <5j et pas de langue framboisée (critère CRASH5). C'est la rougeole, askip faut juste donner du paracétamol. Pas pommade vitamine A pour la rougeole, dans certains cas on peut donner de la vitamine A p.o pour éviter des complications mais là c'était juste paracétamol (100% sure) .

C-est la rougeole r;ponse D . la pommade c-est dans les pays à risque de cécité

Q13: [Question incomplète]

Homme de 35 ans, avec un myélome multiple qui a des douleurs dorsales et lombaires, il est sous morphine 30mg/j les douleurs sont bien contrôlées. Il a cependant une constipation persistante malgré la prise de laxatifs et se plaint d'une sécheresse buccale. Il a des douleurs à la percussion de D10-D11. Le status abdo est dans la norme. Autres paramètres vitaux sp [...] Qu'est ce qui explique sa symptomatologie ?

- A. CRP
- B. Glycémie
- C. Tests hépatiques
- D. Calcémie
- E. Natrémie

Réponse: D (+4), critères CRAB du myélome. E car déshydraté ?

Q14: [Question complète, débattue]

Vous effectuez une visite à domicile chez une patiente de 94 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer modérée. À l'examen, vous observez plusieurs contusions sur son corps. Elle vit avec sa fille de 66 ans, qui s'occupe d'elle au quotidien. Cette dernière explique que sa mère a besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne (alimentation, habillage, etc.) et admet se sentir parfois dépassée, ajoutant que sa mère "la met parfois en colère".

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- A. Demander un placement dans un home
- B. Documenter par photos les différentes contusions
- C. Contacter la médecine légale pour suspicion de maltraitance
- D. Demande d'avis pour mise en danger auprès de l'Autorité de la Protection de l'Enfant et de l'Adulte (APEA)
- E. Hospitaliser la patiente

Réponse: D [Débattue] → je crois que c'est à l'APEA qu'il faut d'abord signaler. Pour moi c'est l'hospit car tu protèges la personne âgée, tu soulages la fille et tu peux faire les démarches dans un second temps de dénoncer au tpae +2

Je pense que tu signales et puis tu peux hospitaliser en même temps.. sûrement l'APEA nous guidera... Possible aussi mais je crois que l'APEA c'est super long comme démarche selon ChatGPT c'est D, hospitalisation seulement si la personne est en danger *imminent* Pourquoi ne pas documenter les lésions le temps de mettre au clair la situation? On sait pas ce que sont les contusions chez une dame âgée c'est fréquent si elle se tappe, la fille a le droit d'être dépassée si elle doit absolument tout faire on est pas du tout sûr qu'elle la frapperait. (+4)

Q15: [Question complète, débattue]

Le lien entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome est déjà bien établie. Mais si vous vouliez faire la première recherche pour prouver que le fait d'inhaler l'amiante donne le mésothéliome, quel type d'étude est le plus approprié? Ils ont aussi mis une phrase pour dire qu'il n'y avait pas de mesure encore prise à l'époque (au début de ton étude) pour l'amiante.

- A. Cas-contrôle
- B. Cohorte
- C. Essai contrôlé randomisé
- D. Transversale

Réponse: A ou B (incertain). Cohorte : on sélectionne un échantillon et on mesure les facteurs de risque puis on suit les participants au cours du temps en observant la survenue de la maladie donne le taux d'incidence. Transversale c'est pour prévalence. Cas-contrôle c'est rétrospectif mais identifier aussi les FR pour une maladie. Randomisé c'est pour les médicaments surtout. Pour moi c'est B ils mettaient vraiment le contexte de « imaginez vous il y a rien du tout pas de prévention encore du mésothéliome blablabla et ils ont pas encore eu de mésothéliome » cas contrôle c'est vraiment regarder les gens qui ont un cancer et voir s'ils ont ou non une exposition, cohorte (même s'il faut 30 ans) c'est regarder si ceux qui sont exposés vont développer une maladie (+2 pour cohorte, je l'avais lu comme ça aussi, c'était expliqué différemment des autres questions cas-contrôle des années précédentes)

Q16: [Question incomplète]

Patiente jeune (genre la vingtaine) qui consulte pour une fatigue avec menstruations abondantes. Le labo montre:

- Hb 122
- Thrombocytes à genre 40 je crois
- Leuco dans la norme

Quelle est la prochaine mesure à faire:

- A. Ponction de moelle
- B. Refaire la mesure avec du sang citraté
- C. Supplémentation en fer
- D. Dosage TSH
- E. Doser la ferritine

Réponse: B [Sûre]

Q17: [Question complète, débattue]

Patiente de 35 ans, G1P0, accouche à 41 semaines après 5 heures de travail. L'accouchement se passe sans souci mise à part l'émission d'un liquide légèrement trouble. A 30 secondes, le nouveau-né émet son premier faible cri. A 1 minute, il présente une FC à 90bpm (norme 80-120 bpm), une respiration irrégulière, des extrémités cyanosées, des gémissements lors de la stimulation et une faible mobilité spontanée.

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge néonatale ?

- A. Ventilation au masque
- B. Pose de cathéter ombilical
- C. Surveiller et refaire le point dans 5 minutes
- D. Libérer les voies aériennes

Réponse : D +7 +chatgpt (j'ai mis C +3 , APGAR a 6 ce bebe va bien) j'ai mis D mais chat est d'avis A +4 APGAR de 5 donc <7 pas top -> nécessité d'intervention supplémentaire, FC <100bpm = ventilation au masque / Les gars on libère les voies aériennes (aspirer les sécrétions) avant de mettre une VNI (+4) l'aspiration des sécrétions ne se fait que selon des indications particulières comme aspiration de liquide meco à cause du risque de lésion des muqueuses (source: formation de réanimation néonatale donnée par le CHUV) et là on parle de ventilation au masque pas de VNI. Je suis d'avis que si tu suis ton ABCDE tu fais d'abord ton A (libérer les voies aériennes) et après ton B (ventilation au masque)

les mesures initiales: le bb on l'emet sur table de rea et on bien respirer (voies aeriennes degagees) si on entend gaggleef le bb doit etre mis sur le dos avec ptite lingette sous la tet permettre de bien respirer

Mesures initiales de la réanimation du N

1. Prévenir l'hypothermie:

- placer le nouveau-né (NN) sur la table préchauffée
- utiliser des linges chauds

2. Libérer les voies respiratoires:

- ev. brève aspiration (bouche avant narine)
- position neutre de la tête

3. Stimulation de la respiration:

- Stimulation tactile

Q18: [Question complète/incomplète]

Jeune patiente, son père est décédé il y a une semaine d'un cancer. Elle se sent triste, mais aussi soulagée que son père ne souffre plus. Elle n'a pas dormi durant plusieurs nuits. Son amie l'encourage à consulter un médecin pour « ne pas louper une dépression au cas où ». Elle se sent relativement bien, souhaite suivre le conseil de son père et « vivre la vie au mieux ». Que lui proposez vous ?

- A. Rejoindre un groupe d'entraide
- B. Psychanalyse
- C. SSRI et anxiolytiques
- D. Psychothérapie sur les traumatismes
- E. Chronothérapie / photothérapie

Réponse: A [Débattue] j'ai mis E +1 car ses symptômes principaux semblaient être la dérégulation du sommeil comme c'était formulé. Imo s'ils voulaient qu'on mette photothérapie ils auraient mis qu'on est en hiver et que chaque hiver elle est déprimée, là elle est en deuil elle a juste besoin de parler avec des gens qui ont vécu la même chose.

Q19: [Question complète]

Homme, environ 70 ans, insuffisance rénale terminale, dialysé 3x/sem depuis 9 ans. Actuellement hospitalisé pour "événement bénin random pas pertinent pour la question". Dit ne plus supporter le poids de sa prise en charge. Les canules, les infections à répétitions, l'impact sur sa vie est devenu trop grand. Il désire un retrait thérapeutique et il demande combien de temps lui faudra-t-il pour mourir.

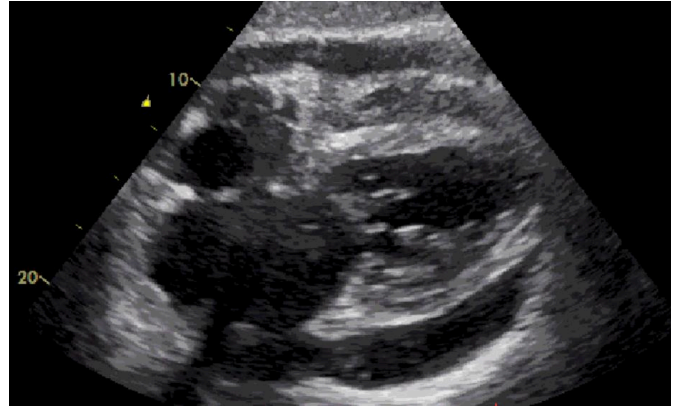
Vous lui répondez :

- A. 48-72h
- B. 1-2 sem
- C. 2-3 mois
- D. Impossible à dire

Réponse : B +6 (pas sûre) D +7 (T'en sais rien si il va pas mourir dans 24h ou 3 semaines non ?). Troubles électrolytiques (hyperkaliémie etc) et toxines (urémiques etc) s'accumulent dans les premiers jours/semaines. En général les insuff. Rénales terminales nécessitant des dialyse constantes tiennent entre 7 à 10 jours. Quelle bande de tdc quand même

Q20: [Question complète]

Jeune homme de 24 ans, arrive aux urgences pour douleur thoracique respiro-dépendante, empirée à la position couchée associée à une dyspnée depuis 24h. Il est en bonne santé habituelle mais relate cependant un épisode d'IVRS il y a 1 semaine. TA: 120/80. FC: 90. Spo2 97%. ECG : Inversion des Ondes T diffuses. Vous faites un POCUS qui montre (c'était une vidéo) :



- A. Myocardite
- B. Syndrome coronarien aigu
- C. Péricardite
- D. Pneumothorax
- E. Dissection aortique

Réponse: C [Sûre] → épanchement péricardique avec hypomotilité du VG

Q21: [Question complète]

Patiente de 36 ans, 3G1P, à 38+6 SA, qui se présente pour des céphalées en casque rapidement progressives. Le conjoint de la patiente trouve que la patiente a le visage gonflé. La patiente rapporte une prise de 3kg en moins d'une semaine. A l'examen clinique nous retrouvons des réflexes hypervifs et extension de la zone réflexogène, OMI. Au stix vous retrouvez une protéinurie. Tension artérielle 185/110. Le CTG est normal, pas de souffrance foetal. Pas de contractions utérines. Enfant en position céphalique. Bilan sanguin dans les normes, stix urinaire montrant une protéinurie. Que faire?

- A. Antihypertenseur IV + sulfate de magnésium IV + accouchement
- B. Antihypertenseur per os et hospitaliser pour surveiller
- C. Antihypertenseur IV + sulfate de magnésium IV + hospitalisation pour surveillance
- D. RAD et rassurer
- E. RAD avec traitement antihypertenseur per os

Réponse : A [Sûre]

Q22: [Question complète]

Patiente de 57 ans qui a subi une splénectomie il y a 3 semaines dans le contexte d'une rupture traumatique de la rate. Elle vient vous voir ce jour au cabinet pour faire le point. Elle est à jour sur toutes ses vaccinations et a été vaccinée contre le pneumocoque il y a 3 ans lorsqu'elle a reçu un diagnostic de BPCO.

Quel vaccin ou rappel doit-elle effectuer dans le contexte actuel ?

- A. Tetanos
- B. Hépatite A
- C. Coqueluche
- D. Méningocoque
- E. Herpès

Réponse: D [Sûre]

Q23: [Question incomplète, débattue]

Patiente de 50 ans adressée aux urgences par son médecin traitant. Elle s'est fait retirer une molaire inférieure y a un mois. Traitée par coamox puis relayé par clindamycine pendant 7j, avec une amélioration initiale puis péjoration au point qu'elle arrive plus à dormir. Image bien dég avec grosse excroissance tissulaire (c'était pas juste mega gonflé inflammatoire?) et saignement au niveau du lieu d'extraction.



Truc +- degeu comme ca (c'était pas vraiment un trou cetait genre...une excroissance chelou œdématiée qui avait l'air d'avoir saigné)

Que faire ?

- A. Biopsie
- B. Changer d'antibio
- C. SPECT CT
- D. Révision chirurgicale
- E. Hémostase
- F. :) Retourner voir son dentiste qui a fait de la merde psk on y connait rien nous avec les dents (AH BAH NON c'était pas une proposition... dommage)

Réponse: A [Débattue] désolée je sais pas je suis pas dentiste et je trouve pas de photos A? Révision chir non ? (ça saignait et c'était franchement pas beau) D? abcès/surinfection dégueu? A. Ca avait l'air bien dég, pour moi plutôt tumoral +3. D car douleurs pas classiques d'une tumeur buccale, post extraction est classique. Clinique initiale incompatible je pense

Q24: [Question complète]

Patiente de 54 ans congolaise, qui se présente pour une fatigue et des céphalées depuis 4 mois. Elle est en BSH hormis une crise de goutte inaugurale il y a deux mois et du prurit. Tension 148/88, autres pv dans la norme. BMI à 34. Lésions de grattage sur le corps.

Hb à 181, erythrocytes a 7.25 (augmenté), leuco et thrombocytes dans la norme, répartition normale, EPO abaissée.

- A. Oxymétrie nocturne
- B. Cytométrie de flux
- C. Electrophorèse de l'hémoglobine
- D. Recherche de mutation JAK2
- E. Recherche de parasites dans les selles

Réponse: D [Sûre]

Q25: [Question complète]

Femme de 50 ans, premier rdv chez un nouveau médecin traitant. Elle a eu un accident il y a 10 ans avec un cou du lapin. Cervicalgies chroniques depuis cet incident. Elle a déjà fait beaucoup d'investigations chez son médecin d'avant, dont une IRM du dos normale ainsi qu'une évaluation ortho normale. Elle a beaucoup lu sur internet et a peur d'avoir une fibromyalgie. Elle a une mère et un frère atteints de psoriasis. Labo: CRP à 20

Vers quelle direction faut-il orienter la suite de la prise en charge pour cette dame?

- A. En Rhumatologie
- B. En Psychiatrie
- C. En Orthopédie
- D. Arrêter les investigations
- E. Médecine complémentaire

Réponse: A [Sûre] → suspicion d'arthrite psoriasique

Q26: [Question incomplète, débattue]

Maman qui vient avec son fils de 10 ans psk elle dit qu'il ne mange plus rien, qu'il a perdu bcp de poids etc. Il se situe au 10ème percentile pour son poids par rapport à son âge. Lorsqu'on interroge l'enfant répond qu'il ne veut pas en parler et présente un comportement opposant. Auparavant il avait un poids normal. Il n'a aucun autre symptôme. Que faites-vous ?

- A. Rien, il ne souffre pas d'un TCA
- B. On le réfère à un spécialiste pour suspicion de TCA
- C. On le réfère à un centre de pédiatrie pour suspicion de TCA
- D. On demande à la maman de noter ce que l'enfant mange pendant 1 semaine puis contrôle
- E. On explique les risques des TCA à la mère et au fils et on le revoit dans 6 semaines

Réponse: (Débattue) D +3 (regarder si vraiment il ne mange pas assez, ou pas normalement avant de l'envoyer vers un centre spé pour les TCA non ? pour moi ultra anxiogène de faire ça avec un gosse probablement TCA? surtout s'il y est opposant?, B +6, perso E+4) moi j'ai mis A + 2 en tout cas mais visiblement je suis la seule. A aussi

Q27: [Question complète]

Une femme de 22 ans connu pour un trouble borderline a décidé d'avaler une pile bouton. Elle vient aux urgences sans aucun symptôme. Au Rx thorax on retrouve la pile dans le tiers moyen de l'oesophage. Quelle est la suite de votre prise en charge ?

- A. Provocation de vomissements
- B. CT thoraco-abdo
- C. Administration de prokinétiques
- D. Retirer la pile par fibroscopie
- E. Rien faire pour l'instant contrôl le lendemain

Réponse: D [Sûre] → si tu l'enlèves pas t'as un risque de lésion hardcore et de perforation de l'oesophage

Q28: [Question incomplète]

Homme de 55 ans avec douleurs nucales. Il se lève un matin et voit son œil qui ressemble à ça.



Quel est le diagnostic ?

- A. Dissection carotidienne
- B. Myasthénie grave
- C. AVC
- D. Thrombose du sinus caverneux
- E. ?

Réponse : A [Sûre]

Q29: [Question complète, débattue]

Une patiente de 49 ans, G3P3, obèse et tabagique 25 UPA, se présente aux urgences gynécologiques pour des saignements vaginaux indolores. Elle rapporte un épisode similaire il y a 3 mois, ayant duré 6 jours. Son état général est conservé et ses paramètres vitaux sont stables.

Examen clinique : au spéculum: présence de caillots de sang frais dans le vagin, col utérin normal. Toucher vaginal : pas d'anomalie au niveau des annexes et palpation indolore

Échographie endovaginale : Utérus semble augmenté de volume avec un présence d'une masse intramurale postérieure de 9 cm. Un Endomètre épaissi à 18mm (ou 16mm?) et irrégulier, avec hypervascularisation. Les Annexes sont sans particularité.

Quelle est la prochaine démarche qui confirmera le diagnostic le plus probable ?

- A. TDM abdomino-pelvienne
- B. Biopsie de l'endomètre
- C. IRM abdomino-pelvienne
- D. Test de grossesse
- E. US abdominal

Réponse: B +8- endomètre très épaissi

C pour moi clairement tu fais une IRM! +2 elle est potentiellement encore menstruée, elle a eu trois grossesses protectrices du cancer de l'endomètre, elle a une masse intramurale...parle pour un fibrome. L'us c'était pas une option. / comment expliquer endomètre épaissi ? Il y a un fibrome intramural postérieur mais pourquoi l'endomètre est

épaisse? Elle possède quand même un facteur de risque d'obésité fumeuse (donc plutôt exclure le cancer tout de même ?)

Plutôt diagnostic de fibroléiomyome/adenomyose > ça se diagnostique par biopsie

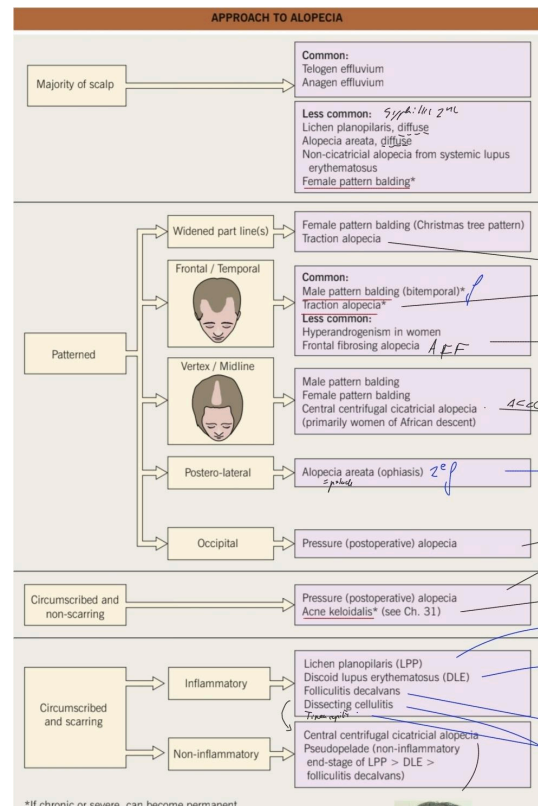
Q30: [Question incomplète]

Femme d'une trentaine d'années, sous contraceptifs, alopecie en plaque avec perte de cheveux facile lors de la traction des cheveux au bord de la plaque. À l'examen, on voit des follicules pileux encore formés mais vides.

Quel est le diagnostic ?

- A. Alopecie areata
- B. Trichillomanie
- C. Teigne
- D. Alopecie androgénétique
- E. Effluvium telosum

Réponse : A,E [Débattue] (apparemment sur Amboss typique quand on tire mini peu ça part)/ Alopecia areata (ça ressemble vachement). Pas E car est diffus hors ici c'est à un endroit précis. La perte de cheveux au tirage n'était que sur les bords de la plaque et non tout le scalp donc plus areata -> A +7



Q31: [Question incomplète]

Patiente de X années, connue pour un carcinome mammaire traité par ?, et pour une FA anticoagulée. Elle se présente en raison d'une dyspnée. À l'auscultation, vous notez un murmure respiratoire réduit en base gauche. Le rythme cardiaque est irrégulier. La patiente est stable et ne désature pas.

Vous réalisez un POCUS montrant :

Quel serait la prise en charge adéquate ?

- A. Ponction pleurale en urgence
- B. Thoracotomie avec talcage en urgence
- C. Diurétiques intraveineux
- D. Ponction pleurale élective après avoir arrêté l'anticoagulation
- E. ?



Réponse: D [Sûre] → carcinose pleurale sur carcinome mammaire donc indication à ponction diagnostique mais sans urgence donc on peut/doit arrêter l'anticoagulation

Q32: [Question incomplète] (ANCORAGE)

Patiente de 70 ans, incontinence fécale. Photo + deg que celle-là.

Quel diagnostic ?

- A. Prolapsus rectal
- B. Prolapsus anal
- C. Hémorroïdes
- D. Cancer
- E. ?



Réponse: A [Sûre]

Q33: [Question complète]

Femme de 46 ans qui vient chez son généraliste pour des questions sur le dépistage du cancer. Elle n'a eu aucun suivi médical depuis 20 ans. Elle n'a pas d'antécédents familiaux de cancer. Elle a fumé 5 cigarettes par jour pendant 10 ans mais a arrêté à 33 ans. Que lui conseillez-vous?

- A. Mammographie
- B. CT abdo low dose
- C. Cytologie col de l'utérus
- D. Colonoscopie
- E. Ne rien faire

Réponse: C [Sûre] → pas la A car mammographie de dépistage à partir de 50 ans

Q34: [Question incomplète, débattue]

Patient de 19 ans qui se rend aux urgences. Anamnèse impossible car alcoolisé. Tuméfaction auriculaire.

Quel diagnostic ?

- A. Otohématome
- B. Périchondrite
- C. Basaliome
- D. Zona
- E. Erysipele



Réponse: A ? B ?- A (sure)

Q35: [Question incomplète]

Patiente de 63 ans qui se rend chez son médecin traitant en raison de fatigue, constipation et prise de poids récente. Le laboratoire effectué montre une TSH élevée, une T4 légèrement abaissée, des anticorps anti-TPO positifs et des anti-TRAK négatifs. L'échographie montre une thyroïde relativement petite, irrégulière et sans nodules.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Basedow
- B. Macroadénome hypophysaire
- C. Thyroïdite de Quervain
- D. Thyroïdite de Hashimoto
- E. Goître sur carence en iode

Réponse: D [Sûre]

Q36: [Question complète]

Fille de 15 ans qui, depuis quelque temps, voit ses résultats scolaires baisser. Emmenée par ses parents car inquiets.

Une fois que les parents sont partis, la fille dit qu'elle consomme du cannabis le soir après l'école avec une amie (4-5 joints par semaine), principalement pour se détendre. Conso d'alcool occasionnelle le week-end de temps en temps. Elle n'a pas très envie que ses parents soient au courant.

Que faire ?

- A. Faire un suivi pédopsychiatrique
- B. Référer à un centre spécialisé dans les addictions
- C. Explorer les raisons de sa consommation
- D. Avertir les parents de la consommation de leur fille

Réponse: C [Sûre]

Q37: [Question complète] (ANCRAGE)

Une patiente de 3 ans vient consulter au cabinet de dermatologie. Elle présente depuis 2 ans des lésions cutanées eczémateuses avec démangeaison sur les joues, coudes, poignets et creux poplités. Le traitement local de crème aux corticoïdes apporte un soulagement rapide mais de courte durée. A l'examen actuel, elle présente peu de signes. On note une sécheresse générale de la peau.

Quel élément supplémentaire parle le plus en faveur du diagnostic probable ?

- A. Rhagades sous-auriculaires
- B. Gonflement généralisé des ganglions
- C. Fissure anale
- D. Kératose palmoplantaire
- E. Dermographisme urticarien

Réponse: A [Sûre]

Q38: [Question incomplète]

Patient psychotique avec schizophrénie chez qui on décide d'instaurer un traitement par clozapine. Lequel des effets secondaires suivants doit être recherché régulièrement lors des consultations ?

- A. Hypothyroïdie
- B. Reflux gastrique
- C. Agranulocytose
- D. Neuropathie
- E. ?

Réponse: C [Sûre]

Q39: [Question complète, débattue]

Une patiente de 60 ans avec cirrhose éthylique Child C, et varices œsophagiennes qui ont préalablement mené à une hémorragie digestive. Elle est en état de choc. Ceci a motivé la mise en place d'un traitement par bêta-bloquants ainsi que la ligature initiale de 5 varices, qui échoue et le saignement reprend. Un ballon de compression est alors mis en place pour contenir l'hémorragie. La patiente est bradycarde à 54bpm.

Quelle est la suite de la prise en charge ?

- A. Angioembolisation des artères œsophagiennes
- B. Gastrocopie le lendemain avec nouvelle ligature endoscopique des varices
- C. Majoration du traitement par bêtabloquant
- D. TIPS (Transjugular Intrahépatique Portosystémique Shunt)
- E. Transplantation hépatique d'urgence
- F. Œsophagectomie distale avec anastomose

Réponse: D? B? → Child-C = probablement encéphalopathique, ce qui contre-indique un TIPS (c'est une contre-indication relative, j'imagine que au vu de l'état de choc on privilégie la survie plutôt que l'aggravation d'une encéphalopathie ? +1)
(il me semble pas que la ligature à nouveau faisait partie des réponses-> oui)

Q40: [Question incomplète]

Jeune patiente, se plaint de fatigue + perte de poids ??? TA à 70/40, FC 110, A remarqué qu'elle était plus bronzée que d'habitude, je me rappelle plus du reste

On a déjà commencé le remplissage, que faire d'autre ?

- A. Hydrocortisone
- B. Adrénaline
- C. Noradrénaline
- D. Sucre
- E. Phényléphrine

Réponse: A+7 [Sûre] → insuffisance surrénalienne aiguë → déficit cortisol → ACTH +++ → Msh → bronzage peau

Q41: [Question complète, débattue]

Patiente de 68 ans, qui consulte aux urgences pour une dyspnée aiguë d'apparition soudaine. Il y a 3 jours la patiente a été traitée par angioplastie pour un infarctus du myocarde. Elle a quitté l'hôpital contre avis médical de manière prématurée la veille. La patiente a les lèvres cyanosées et une acrocyanose. Elle sature à 82% à l'air ambiant. Température à 36.6, TA 112/96. A l'examen clinique vous auscultez des râles diffus sur toutes les plages pulmonaires qui vous empêchent de d'ausculter le cœur. Pas de douleurs thoraciques. L'ECG de la patiente est superposable à son ECG de sortie.

Quel diagnostic suspectez-vous ?

- A. Infarctus du myocarde
- B. Péricardite
- C. Embolie pulmonaire
- D. Rupture d'un muscle papillaire
- E. Tamponnade

Réponse: [Sûre]: D + 7

La rupture du muscle papillaire c'est typiquement après 1-4 semaines de l'infarctus; 3 jours c'est shortos quand même. J'ai mis B parce que chronologiquement ça collait le mieux. Niveau clinique c'est moyen ceci dit. Pourquoi pas E??

Q42: [Question incomplète] (ANCORAGE)

Garçon de 13 ans, douleur de hanche. IMC à 30.1 ? La radiographie montre (sans la ligne bleue évidemment) :

Quel est le diagnostic ?

- A. Maladie de Legg-Calvé-Perthès
- B. Épiphysiolyse fémorale
- C. Rhume de hanche
- D. ?
- E. ?



Réponse: B [Sûre]

Q43: [Question incomplète, débattue] (ANCRAGE)

Question relou du gosse qui a fait une commotion cérébrale ya 48h en faisant du hockey avec pseudo perte de connaissance de 15min. Ce jour, sa mère le trouve toujours ralenti. Le status neurologique est sans particularité. Il a cependant mal à la tête en sautant sur place. Sa mère se demande si elle peut le laisser reprendre le hockey le lendemain pour un nouveau match.

Quelle est la prise en charge adéquate ?

- A. CT cérébral avant de reprendre le sport
- B. Hospitalisation
- C. Observation pendant 48h par les parents, à hauteur de 4x/j
- D. Le patient décide s'il veut reprendre le hockey le lendemain
- E. Stop le sport jusqu'à disparition des céphalées

Réponse : A ? E +8? [Débattue] Perso je lui dit de stop le sport (commotion sur commotion c'est mauvais, normal d'avoir des maux de tête plusieurs heures après une forte commotion, le status neuro est normal)

Q44: [Question incomplète, débattue]

Femme de 48 ans, connue pour un diabète de type 2 traitée par metformine et dapagliflozine. Elle souhaite perdre du poids, elle a déjà fait plusieurs régimes qu'elle a trouvés sur Internet mais rien n'est efficace sur le long terme. Elle a un BMI à 28.2. (c'était pas moins que 28 ? oui c'était moins que 28, 27 je pense)

Que lui proposez vous ?

- A. Ajuster le traitement de son diabète
- B. Proposer une consultation bariatrique
- C. Proposer une consultation en diabétologie
- D. Prescrire une thérapie nutritionnelle
- E. Ne rien faire

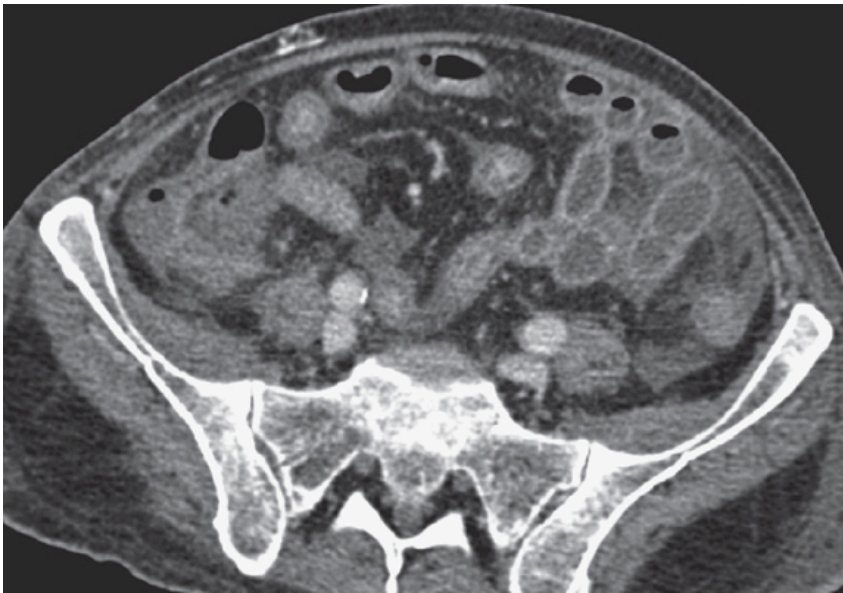
Réponse: [Débattue] E ? J'ai mis D (c'est son envie de perdre du poids et une mesure qu'on n'a pas encore proposé c'est la diet +10). J'ai mis C pour qu'ils la mette sous semaglutide ou un bail comme ça. Le diabète était équilibré donc je pense pas qu'il faille changer le ttt antidiabétique mais plutôt la rediriger vers un nutritionniste. Au CHUV les diabéto proposent traitement par Ozempic j'ai mis ça aussi.

Pas sur que ozempic soit indiqué pour un BMI à 28. Pour moi d'abord mesure nutritionnelle suivie par un pro avant d'envisager qqch de plus sérieux+3

Q45: [Question complète]

Patient de 85 ans institutionnalisé pour démence en EMS. Connu pour une cirrhose hépatique Child-Pugh C est amené aux urgences pour des douleurs abdominales diffuses. Le patient a 37.2°C, 100/80 TA, 80 bpm.

L'examen abdominal met en évidence des bruits abdominaux diminués en fréquence mais pas en tonalité. La palpation abdominale ne met pas en évidence de défense ni de détente. L'anamnèse est difficile et n'offre pas plus d'information en raison de l'état cognitif du patient. Un CT scan est réalisé et montre cette image :



Quel est le diagnostic le plus probable compte tenu de l'histoire clinique et de l'imagerie ?

- A. Hydronéphrose
- B. Iléus mécanique
- C. Entérite
- D. Pancréatite

Réponse : C [Sûre] (Image de l'examen assez similaire avec infiltration de la graisse abdominale et quelques ganglions mésentériques)

Q46: [Question complète]

Patiente de 80 ans habite dans un home. La patiente est autonome pour les AVQ. Elle s'est fait opérée pour une prothèse de hanche il y a 2 mois en raison d'une coxarthrose et est substituée pour une hypothyroïdie depuis 2 semaines. . La patiente a aussi bénéficié d'une thérapie par escitalopram débutée il y a 2 jours. La patiente est amenée aux urgences car elle a été retrouvée en train d'errer dans les couloirs du home, confuse, à la recherche de son mari qui est décédé il y a 6 ans. Les paramètres vitaux sont : TA 110/85, 37,6°C, 90bpm.

Status met en évidence une cicatrice au niveau de la hanche calme, légèrement tuméfiée. Un liquide légèrement trouble s'échappe des bords chirurgicaux lorsqu'on appuie dessus.

Le labo montre Na 136, CRP à 120, Leuco à 14, urée à 12

Parmi les propositions suivantes, laquelle explique le mieux l'état confusionnel de la patiente ?

- A. Hyponatrémie
- B. Infection de la prothèse de hanche
- C. Urémie
- D. Thyrotoxicose

Réponse: B [Sûre]

Q47: [Question incomplète]

Vignette d'une patiente de 55 ans ayant fait de la peinture au plafond de son appartement. Depuis, elle se plaint de douleurs nucales et autres symptômes neurologiques cérébelleux (instabilité à la marche, vertiges, etc)

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. AVC sur dissection vertébrale
- B. ?
- C. ?
- D. ?
- E. ?

Réponse: A [Sûre]

Q48: [Question incomplète : valeurs approximatives]

Patiente anorexique hospitalisée avec un BMI à 12 (?). Pas de plainte.

Na 133 (norme 135-145)

K 3.6 (norme 3.5-5.0)

Mg 0.68 (norme 0,74-1,07 mmol/L)

P 0.7 (norme 0.8-1.45 mmol/L)

créat 18 (norme 50-100 umol/L)

Que faut-il surveiller en priorité ?

- A. Sodium
- B. Magnésium
- C. Phosphate
- D. Créatinine

Réponse: C +4 (L'hypophosphatémie est le principal indicateur biochimique du syndrome de réalimentation, d'après AMBOSS) [Débattue]A? pour risque cardio (aucune idée)

Q49: [Question incomplète]

Étudiant stressé pour les examens de maturité, bili totale augmentée, bili indirecte augmentée, ictère.

Quelle prise en charge est la plus adaptée ?

- A. Rien
- B. ERCP
- C. Albendazol
- D. Drainage des voies biliaires sous CT
- E. Ciprofloxacine et metronidazole

Réponse : A [Sûre] → syndrome de Gilbert

Q50: [Question complète] (ANCRAGE)

Patient fumeur de 76 ans, connu pour une hypertension artérielle, qui présente depuis plusieurs mois des douleurs dans les jambes apparaissant après 600 mètres de marche. Le patient n'a pas de symptômes au repos et la nuit. Une échographie réalisée par le passé montre une occlusion de l'artère fémorale superficielle jusqu'au creux poplité, avec collatérale qui ont pris le relais. La symptomatologie est stable depuis 6 mois.

Que préconisez-vous pour la suite de la prise en charge?

- A. Un stent de l'artère poplitée
- B. Une coronarographie
- C. Un pontage fémoropoplité
- D. Entraînement à la marche et arrêt du tabac
- E. Ne rien faire.

Réponse: D [Sûre] → IAMI stade IIa

Q51: [Question complète]

Patiente d'environ 30 ans, graphiste, qui consulte son médecin traitant pour un épuisement professionnel. Elle aime son travail mais a récemment été changée de secteur. Maintenant le travail est plus répétitif et elle ne s'entend pas bien avec son nouveau chef qu'elle décrit comme dénigrant et cassant. Elle est anxieuse, se dévalorise, dort mal, et est anxieuse à l'idée d'aller au travail le matin.

Quelle prise en charge ?

- A. Prescrire des anxiolytiques et antidépresseurs
- B. Lui conseiller de démissionner et s'inscrire au chômage
- C. Réorientation professionnelle
- D. Contacter une entreprise de médecine du travail accréditée pour une inspection de l'entreprise
- E. La mettre en arrêt de travail pour une durée déterminée et réévaluer

Réponse: E [Sûre]

Q52: [Question incomplète, débattue]

Femme de 70ans qui n'est pas allée chez le médecin depuis 20ans connue pour une HTA et un diabète non traités. Elle vous rend visite parce que depuis une semaine elle a un essoufflement nouveau (NYHA II). Au status vous voyez une distension jugulaire, des OMIs jusqu'au genou. À l'auscultation vous entendez des râles pulmonaires aux deux plages. Qu'est ce qui est **nécessaire** pour poser le diagnostic?

- A. Troponines
- B. Pro- BNP
- C. D-dimères
- D. Créatinine kinase (CK)
- E. Rien faire, le diagnostic est clinique

Réponse: b+3 [Sûre / Débattue] E +3 ? C'est clinique une IC non? Elle était pas aussi déjà connue pour un NYHA stade II? Oui la clinique suit mais il me semble que NT pro bnp bonne VPN c'est pour ça qu'on l'utilise en plus de la sévérité de l'IC.

Amboss: HF is confirmed if a patient has [clinical features of HF](#) attributable to structural or functional cardiac abnormalities and **either**: [1][2]

- Elevated natriuretic peptides
- **Evidence of cardiogenic pulmonary or systemic congestion**

E +1, (C+2, il faut NT-Pro-BNP NT-proBNP > **125 pg/mL** en situation stable ou NT-proBNP > **300 pg/mL** en aigu non ?) [Sûre / Débattue]

J'ai mis C, il me semble que pour poser le dx d'IC il faut signes/symptômes + modifications cardiaques structurelles/fonctionnelles. +1

Selon SURFmed: "Le diagnostic d'une IC ne dépend ni des taux des BNP ni de la présence d'une éventuelle anomalie structurelle cardiaque"

Ouais mais en même temps dans la question il y avait aucune notion qu'elle avait déjà eu des événements ou antécédents cardios donc je trouve pour une insuffisance chez qqn qui (a notre connaissance) n'a "que" diabète et HTA on peut justifier de faire une BNP ?

Q53: [Question complète] (ANCRAGE)

Femme de 43 ans qui a une sclérose systémique cutanée limitée qui vient car dyspnée progressive, depuis 2 semaines, surtout à l'effort, radio thorax normal, qu'est-ce qui explique les symptômes qui viennent de la sclérose systémique?

- A. Myopathie
- B. Myocardite
- C. Épanchement péricardique
- D. Hypertension artérielle pulmonaire
- E. Expansion thoracique compliquée en raison de la sclérodermie cutanée

Réponse: D [Sûre] + 4 mais c'est batard pske ça fait aussi une myocardite

Q54: [Question complète, débattue]

Patient de 52 ans qui travaille dans la métallurgie. ATCD d'un AVC thalamique il y a un an avec récupération complète sur le plan symptomatologique. Depuis le patient est traité avec atorvastatine 20mg et aspirine 100mg. Au laboratoire on trouve une thrombocytose à 800 isolée. A savoir que les thrombocytes étaient déjà à 780 lors du bilan réalisé lors de son AVC

Quel diagnostic ?

- A. Saturnisme
- B. Anémie pernicieuse
- C. Syndrome myéloprolifératif
- D. Effet secondaire de l'aspirine
- E. Leucémie lymphoïde chronique

Réponse: Saturnisme? (Ça sonne bien vu que ça ressemble aux Saturnales)=intox au plomb [Débattue] symptômes de LMC donc C j'imagine. C +1 —> Thrombocytose isolée chronique

Q55: [Question complète]

Patiente de 87 ans vivant en EMS est amenée aux urgences car elle a été retrouvée en train d'errer dans le couloir à 2 heures du matin à chercher son mari décédé il y a 6 ans. C'est ce jour la première fois que cela lui arrive. Une femme connue pour hypothyroïdie substituée et des troubles cognitifs légers. Une patiente habituellement autonome pour la plupart des activités de la vie quotidienne.

Récemment, son généraliste a introduit de l'amitriptyline en raison de troubles du sommeil récemment apparus.

À quel diagnostic pensez-vous ?

- A. Délire anticholinergique
- B. AVC
- C. ECA post-ictal
- D. Thyrotoxicose
- E. Hydrocéphalie

Réponse: [Sûre] A

Q56: [Question incomplète]

Homme de 42 ans hospitalisé en raison d'une fracture du tibia de la jambe gauche, attend d'être opéré.

Développe soudainement des douleurs exquises à la jambe gauche qui ne cèdent pas aux opiacés même hautes doses. Oedème présents sans signe du Godet, pouls palpable, sensibilité et motricité conservées mais le patient a très mal lorsqu'il mobilise ses orteils.

Quelle est votre prise en charge ?

- A. Fasciotomie en urgence
- B. Glace et surélévation
- C. D-dimères
- D. Anticoagulation

Réponse: [Sûre] A

Q57: [Question complète]

Jeune femme de 42 ans qui se présente avec nausées et vomissements depuis 2j et douleur à la palpation de l'épigastre..

Labo hémoglobine 119, leucocytes 12.7, thrombocytes 980.

Vous réalisez une échographie qui montre une thrombose de la veine splénique avec une légère hépatosplénomégalie.

Quelle maladie recherchez vous ?

- A. Thrombocytémie essentielle
- B. Leucémie myéloïde chronique
- C. Polycythemia vera
- D. Microangiopathie thrombotique
- E. Anémie hémolytique

Réponse: A [Sûre]

Q58: [Question incomplète, débattue]

Jeune femme de 28 ans qui se présente dans votre cabinet parce qu'elle est très triste.

Depuis 3 jours elle se sent triste, n'éprouve plus de plaisir. Lorsque vous insistez, elle admet présenter des idées noires. Il y a 1 semaine, elle s'est faite quittée par son compagnon et dit être très désespérée.

À quel diagnostic pensez-vous ?

- A. Episode dépressif sévère
- B. Episode dépressif léger
- C. Trouble de la personnalité de type émotionnellement labile
- D. Trouble de l'adaptation
- E. Trouble de la personnalité de type dépendance affective

Réponse: D [Sûre] → Selon les critères du DSM-V, il n'y a pas de durée minimale pour le trouble de l'adaptation. Cependant les symptômes ne doivent pas persister plus de 6 mois si le facteur de stress ou ses conséquences ont disparu.

Q59: [Question incomplète]

Patiente de 68 ans présente depuis 3 mois des pertes d'urine lors d'effort ou de rire. Pas de dysurie, pas d'hématurie.

- A) Physio du plancher pelvien
- B) Fosfomycine
- C) Bouchon en liège +1
- D) Alpha antagoniste (tamsulozine)
- E) Inhibiteur M3
- F) Sympathomimétique

Réponse: : A [Sûre]

Q60: [Question incomplète, débattue]

Patient de 32 ans connu pour un HIV de type I traité depuis 2 ans, il a des CD4 à 540 (dans la norme). Il consulte car il présente depuis hier une éruption sur tout le corps sans prurit associé. Il a des rapports sexuels protégés mais admet avoir eu des rapports oraux non protégés. Il n'y a pas de lésion actuellement au niveau génital.

(c'était pas ça l'image mais j'ai pas trouvé plus ressemblant)

Quelle est votre approche ?

- A. Dépistage syphilis
- B. Chercher HHV 6
- C. Chercher HHV 8
- D. Tester la virémie VIH
- E. PCR gonocoque



Réponse : A? +6 les CD4 sont normaux donc on recherche pas des germes opportunistes, et si HIV il est à risque pour syphilis aussi. B? +4 (dans l'examen pas exactement la même photo que ci-dessus) Rash plus éparpillé sur tout le tronc

Q61: [Question complète]

Enfant de 8 mois avec strabisme identifié par les parents il y a 2 jours (je crois que dans la question c'était vrm tourné comme si c'était un strabisme "aigu"). Que faut-il faire?

- A. Thérapie par des exercices oculaires
- B. Rassurer les parents et RAD
- C. Occlusion de l'œil qui va bien
- D. Chirurgie
- E. Fond d'œil

Réponse: E [Sûre] → toujours exclure un rétinoblastome

Q62: [Question complète]

Un homme de 75 ans connu pour une FA est adressé aux urgences par son médecin traitant pour une douleur abdominale violente. Pendant son attente aux urgences, ça va mieux donc il veut rentrer. A l'examen clinique, son ventre est ballonné et sensible à la palpation, sans péritonisme. Les analyses sanguines révèlent une CRP augmentée et une leucocytose. Il a présenté un épisode de selles sanguinolentes durant son séjour aux urgences. Quel diagnostic ?

- A. Diverticulite
- B. Cholecystite
- C. Infarctus mésentérique
- D. Cancer pancréas
- E. Pseudokyste du pancréas

Réponse: C [Sûre] → triade FA + diarrhée sanglante + douleur

Q63: [Question incomplète]

Homme de genre 35 ans qui consulte pcq ça le gratte et apparition de lésions depuis 2 ans.



(sur l'image y'avait une "papille", en regard du Stenon)

Quel est le diagnostic ?

- A. Candida
- B. Réaction médicamenteuse
- C. Lichen plan
- D. Leucoplasie

Réponse: C [Sûre]

Q64: [Question incomplète]

Vignette d'un probable glaucome à angle fermé (œil dur, perte de vision).

Quel traitement ?

- A. Corticostéroïdes topiques
- B. AINS topiques
- C. Acétazolamide IV
- D. IRM orbitaire et cérébrale
- E. ?

Réponse: C [Sûre]

Q65: [Question incomplète] (ANCRAGE)

Ethique: patient OH, child C, nous dit qu'elle veut qu'on la laisse mourir, ne veut plus de ttt. Patiente de plus de 60 ans, après un séjour au soins intensifs pour une hémorragie digestive, transférée en chambre...

Quelle prise en charge:

- A. On demande au psychiatre une éval de la capacité de discernement
- B. Plan de soins dirigé
- C. Lui donner des benzodiazépines afin de diminuer son anxiété
- D. ?
- E. ?

Réponse: B [Sûre] → pas besoin d'être psychiatre pour évaluer la capacité de discernement, tout médecin peut le faire

La question était formulée différemment, on voulait demander un bilan psy pour une évaluation de la capacité de discernement, pas demander un avis à un psychiatre.

Q66: [Question complète, débattue]

Homme de 80 ans, connu pour un cancer de la prostate avec sonde à demeure et une HTA traitée et un dément, se présente au cabinet de son généraliste et se plaint de douleurs dorsales basses depuis 4j. Sa température est de 38.6° et il est confus. L'examen retrouve une douleur exquise à la percussion de L1-L2, sans autres signes (notamment pas d'anomalie à l'examen neurologique). Le bilan biologique met en évidence des leucocytes à 13 et une CRP à 250 (n<5).

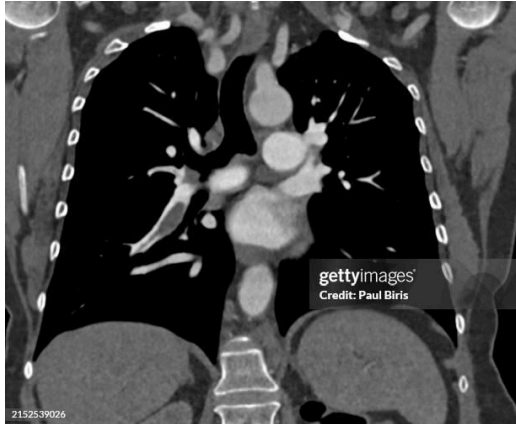
Quel examen vous permettra de poser le diagnostic suspecté ?

- A. Radio du rachis
- B. US de l'abdomen
- C. IRM lombaire
- D. PET-CT
- E. Scanner

Réponse: C +6 pour spondylodiscite = IRM, métastase osseuse (PET CT) peu probable car fièvre et aigu. B car clinique de pyélo

Q67: [Question complète]

Patient de 75 ans, 2 jours post op (on ne sait pas quelle opération), vient chez vous pour douleurs thoraciques aiguës, dyspnée et tachycardie. 3 coupes de CT et on demande quel est le diagnostic le plus probable selon les images radiologiques ?



- A. Collapsus pulmonaire
- B. Embolie pulmonaire
- C. Dissection aortique
- D. Pneumonie

Réponse: B [Sûre] → EP centrale droite

Q68: [Question complète]

Une jeune patiente consulte après une chute sur l'épaule droite lors d'un match de hockey sur glace. L'examen clinique et les radiographies confirment une luxation antérieure de l'épaule droite. La réduction est réalisée en consultation.

À l'examen post-réduction, on note une hypoesthésie dans la région latérale de l'épaule, en regard du deltoïde droit.

Quel nerf est le plus probablement lésé ?

- A. Nerf axillaire
- B. Nerf radial
- C. Nerf musculo-cutané
- D. Nerf cutané médial de l'avant-bras
- E. Nerf médian

Réponse: A [Sûre]

Q69: [Question complète]

Votre collègue de 26 ans médecin assistante devient de plus en plus fermée et ne communique plus. De plus, elle a de la peine à écouter les patients et à se concentrer ce qui mène à des prescriptions et des conseils aux patients inadéquats ainsi que des oublis de traitements médicaux. Elle est à un délire paranoïaques. L'autre jour vous l'avez même surprise en train de parler seul dans le bureau comme si elle avait une discussion avec quelqu'un qui n'était pas là

Quentin faites vous

- A. Vous lui conseillez d'aller voir un psychiatre
- B. Vous prévenez votre supérieure hiérarchique
- C. Vous prévenez les proches de votre collègue
- D. Vous vérifiez toutes les prescriptions qu'elle fait

Réponse: B [Sûre]

Q70: Une dame de 76 vous consulte pour un contrôle car elle n'en a pas eu depuis un certain temps. Le bilan biologique révèle une glycémie à 22 mmol/L, et HbA1c à 11%, ainsi qu'une insuffisance rénale chronique avec un GFR à moins que 15. Quel est le traitement que vous allez instaurer en première intention chez cette dame ?

- A. Metformine
- B. Inhibiteur SGLT2 (Gliflozine)
- C. Inhibiteur DPP4
- D. Insuline
- E. Sulfonurée

Réponse: D [Sûre] → la metformine est CI au vu de l'IR, la gliflozine ne sert à rien sous ce GFR, sulfonurées aussi CI au vu de IR et les anti DPP4 ne sont pas assez suffisants pour faire baisser la glycémie à ce stade, de plus, insuline indiqué si diabète sévère (HbA1c > 10%, glycémie > 17, IRC terminale, diabète gestationnel)

Q71: [Question incomplète]

Choc anaphylactique sur chocolat (RIP) présentait un rash, oedème des lèvres, luette, langue. À l'auscultation présence de sibilances expiratoires

Quelle est la prise en charge immédiate ?

- A. Corticoïdes par voie orale et systémique
- B. Bronchodilatateurs
- C. Antihistaminiques
- D. Adrénaline IM
- E. Un truc inhalé ?

Réponse: D [Sûre]

Q72: [Question complète] (ANCRAGE)

Un père amène son garçon de 5 ans aux urgences car depuis hier soir il présente une douleur du pénis, apparue après sa douche. Voici une image :



Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Balanite aiguë
- B. Paraphimosis
- C. Lichen plan
- D. Eczéma du gland
- E. Prépuce en tablier de sapeur

Réponse: B [Sûre], prépuce en tablier de sapeur = hypospadias

Q73: [Question incomplète]

Intoxication au paracétamol (15g) il y a 9h, patiente éveillée et stable HD, tests hépatiques dans la norme. Le dosage de la paracétamolémie est en attente (5h).

Quelle prise en charge ?

- A. N-acétylcystéine
- B. Hémodialyse
- C. Attente des résultats de la paracétamolémie, et, en fonction, protocole N-acétylcystéine
- D. ?
- E. ?

Réponse : A [Sûre]

Q74: A [Question complète, débattue]

Patiente de 75 ans connue pour maladie d'Alzheimer qui est actuellement hospitalisée dans une unité pour spécialisée dans les démences et qui présente des symptômes de pneumonie. Son fils et sa fille sont à son chevet. La patiente avait écrit dans ses directives anticipées qu'elle ne souhaitait pas avoir de réanimation ni recevoir d'acharnement thérapeutique mais elle n'a pas précisé si cela incluait les antibiotiques. D'un point de vue médical, il y a une indication à donner des antibiotiques. Comment faut-il procéder ?

- A. Le médecin doit prendre seul la décision
- B. Le médecin doit tenir compte de l'avis des proches pour prendre la décision
- C. L'équipe médico-soignante doit prendre la décision
- D. Le médecin doit demander la mise en place d'une curatelle de portée générale
- E. Le médecin doit faire appel aux conseillers éthiques pour décider

Réponse: B +10, E +2 C :'(

Q75: [Question incomplète] (ANCRAGE)

Patiente âgée de X années, consulte en raison de perte du champ visuel et de perte d'acuité visuelle. Vous suspectez une occlusion de l'artère centrale de la rétine. De plus, la patiente se plaint de douleurs aux épaules.

Quelle prise en charge immédiate ?

- A. Radiographies des deux épaules
- B. AngioIRM
- C. Biopsie de l'artère temporale
- D. IRM cérébrale
- E. Glucocorticoïdes

Réponse: E [Sûre] → suspicion de Horton sur polymyalgia rheumatica

Q76: [Question incomplète, débattue]

Patient présentant une récurrence d'une tuméfaction rouge au niveau du sillon interfessier avec écoulement purulent récidivant pas impacté par la défécation.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Abscess péri anal
- B. Sinus pilonidal
- C. Fissure anale
- D. Hémorroïde

Réponse: B (+2)? A?

Q77: [Question incomplète, débattue]

Patiente de 40 ans qui a eu un épisode dépressif diagnostiqué il y a 3 mois, sans symptôme psychotique. Elle prend de l'escitalopram 20mg et dit être constante pour la prise. Son mari est inquiet pour elle, elle a une perte d'appétit, pas d'espoir.

Que faites-vous ?

- A. Augmenter la dose
- B. Doser escitalopram dans sérum
- C. Donner du lithium
- D. Hospitaliser en psychiatrie
- E. Changer l'escitalopram pour un tricyclique

Réponse: E ? J'ai mis E aussi mais après discussion je crois que c'est doser escitalopram pour être sûr que la patiente n'est pas métaboliseur lente. Pour moi A+2 (A n'est pas possible -> ne pas confondre citalopram et escitalopram -> pour le escitalopram la dose max est 20 mg)/ Pour moi B (+2) , 3 mois cest pas trop court pour switch de toute facon? / J'étais aussi pour la B pour vérifier l'observance et si elle ne métabolise pas trop rapidement, mais ChatGPT dit la C pour potentialiser son effet. C'est C : " Traitement des phases aiguës et prophylaxie à long terme de la maladie maniaco-dépressive. Co-médication aux antidépresseurs en cas de dépression grave réfractaire aux traitements habituels (Lithium augmentation therapy)" (Compendium) réfractaire au traitement c'est que t'as utilisé vraiment tout là elle est sous escitalopram 20 depuis 3 mois on peut encore faire des choses avant de la mettre sous Lithium.

Q78: [Question complète]

Patiente de 54 ans, ancienne polytox. Seul médicament actuel : sertraline depuis 5 ans. Se plaint d'une polyurie et polydypsie de plus en plus importante. Elle explique que cela s'est empiré depuis qu'elle a arrêté sa consommation. TA dans la norme. Pas d'oedème. Pas de râles crépitants.

Labo :

- Na 130
- K 3.4
- Osmolalité sérique 270
- Créat dans la norme
- Na urinaire 18
- Osmolalité urinaire 80.

Quel est le diagnostic ?

- A. Diabète de type 2
- B. Polydypsie primaire
- C. Syndrome de Bartter
- D. SIADH sur sertraline
- E. Diabète insipide d'origine néphrologique

Réponse : B [Sûre] → hyponatrémie hypo-osmolaire euvolémique avec natriurèse < 20mM

Q79: [Question complète]

Patiente de 37 ans, post-partum depuis 3 mois, se présente avec rougeur, chaleur et gonflement du sein. Elle a décidé d'elle-même d'arrêter l'allaitement depuis 3 semaines et de prendre de la co-amox pendant 10j, relayé par de la clindamycine pendant 9j sans amélioration. Un US ne retrouve pas d'abcès. Que faire ?

- A. Ajouter un traitement par métronidazole PO pendant 7j
- B. Ajouter un traitement par corticostéroïdes
- C. Changer le traitement par Pipéracilline/Tazobactam IV.
- D. Biopsie
- E. Incision et drainage

Réponse : D [Sûre] → biopsie car suspicion de carcinome inflammatoire du sein (paget)

Q80: [Question complète, débattue]

Patient qui fait un choc septique sur foyer pulmonaire avec IRA. On le traite par ceftriaxone. Il présente aussi de la fièvre et des douleurs articulaires (je crois), on l'hydrate, il se rétablit. Il n'a plus de fièvre. Après 3 jours de traitement et est hémodynamiquement stable mais est anurique. Quelle est la cause de l'anurie ?

Créat J1 : 140

Créat J 2 : 300

Créat J3 : 600

- A. Hypovolémie
- B. Nécrose tubulaire aiguë
- C. Néphrite interstitielle sur ceftriaxone
- D. Glomérulonéphrite post-streptococcique
- E. Rétention urinaire aiguë

Réponse : B (Débattue) +6 C ? (Discuté avec le Chat) la néphrite interstitielle t'aurais d'autres symptômes style GI et rash non ?

Q81: [Question complète]

Patiente d'un peu plus de 50 ans qui présente des symptômes d'iléus, iléus du grêle (marqué dans la vignette). Vous trouvez à l'examen clinique une résistance à la pression au niveau de la zone inguinale droite, érythémateuse et douloureuse à la palpation. CRP augmentée à 20

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Appendicite rétro-caecale
- B. Invagination
- C. Hernie fémorale étranglée
- D. Volvulus
- E. Diverticulite

Réponse: C [Sûre]

Q82: [Question incomplète] (ANCRAGE)

Vignette de cluster headache.

Quelle prise en charge lors des crises?

- A. Oxygène
- B. AINS
- C. Paracétamol
- D. Massage du sinus carotidien
- E. Ne rien faire

Réponse: A [Sûre]

Q83: [Question incomplète] (ANCRAGE)

Patiente (environ 50 ans) connue pour une polykystose rénale autosomique dominante, consulte ce jour pour un mal de tête brutal comme elle n'a jamais connu.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Rupture d'anévrisme
- B. Migraine
- C. Céphalée de tension
- D. ?
- E. ?

Réponse: A [Sûre] → polykystose rénale AD est un FR pour les anévrismes cérébraux

Q84: [Question complète/incomplète]

Patiente qui suit un traitement par chimiothérapie. Se présente ce jour avec des sensations de brûlure, paresthésie, perte des réflexes achilléens bilatéralement.

Quel type de douleur présente la patiente ?

- A. Nociceptive
- B. Psychogène
- C. Neuropathique
- D. Centrale
- E. ?

Réponse: C [Sûre]

Q85: [Question complète]

Patient 39 ans, obèse, HTA, qui consulte chez son médecin traitant pour dyspnée, toux, EF. Avait présenté un rhume avec myalgie avant qui s'était amélioré puis repéjoration récente. À l'examen clinique vous remarquez une légère baisse de l'état général. Signes vitaux dans la norme, FR 16, saturation 96%. À l'auscultation, vous notez une diminution du murmure respiratoire en base droite. A la radiographie on a un infiltrat de la base droite. Frottis PCR COVID neg.

Quelle prise en charge est adaptée ?

- A. Ambulatoire avec amoxicilline
- B. Hospitalisation avec co amox + clarithro+ oseltamavir
- C. Oseltamavir seul
- D. Hospitalisation avec glucocortico + TTT ATB (je sais plus si piptazo ou quoi)

Réponse: A [Sûre]

Q86: [Question incomplète]

En gros une patiente qui est persuadée d'avoir qqch elle a vraiment des symptômes dans tous les sens. On a déjà fait plein d'examens, revenus négatifs.

Que faire?

- A. On refait les examens
- B. On la scanne
- C. Explorer ses croyances et représentations de la maladie
- D. ?
- E. ?

Réponse: C [Sûre]

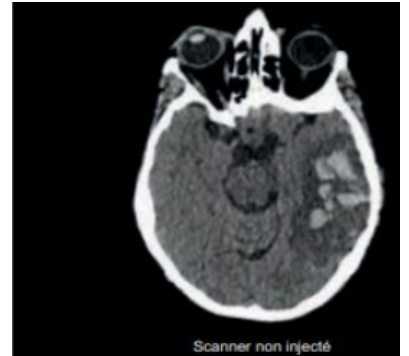
Q87: [Question complète]

Une femme 21 ans de présente pour des une douleur à la tête opressante depuis 4 jours. Douleurs progressives. Elle ne trouve plus les mots. Elle fume 4 clopes par jour depuis ses 16 ans. Tension à 145/90. Elle prend seulement la pilule contraceptive. A part l'aphasie, le status neuro est normal.

Quelle était la cause de ses symptômes ?

- A. Microangiopathie amyloïde
- B. Hypertension artérielle
- C. Thrombose sino-veineuse
- D. Rupture d'anévrisme

Réponse : C [Sûre]



Q88: [Question complète] [ANCORAGE]

Une femme de 45 ans, qui prend du lisinopril et de l'amlodipine pour une hypertension ainsi que de l'atorvastatine pour une hypercholestérolémie. Récemment traitée avec un antibiotique pour une pneumonie, elle se présente avec des myalgies diffuses, une fatigue et des CK nettement élevées. Avec quel antibiotique cette patiente a probablement été traitée ?

- A. Amoxicilline
- B. Azythromycine
- C. Ciprofloxacine
- D. Clarithromycine
- E. Co-Amoxicilline

Réponse: D [Sûre]

Q89: [Question complète]

Un agriculteur de 54 ans consulte tôt aux urgences. Il est somnolent (glasgow 8) et fébrile à 39.5°C. Sa femme dit que durant cette nuit il s'est plaint de vertiges et de douleur aux oreilles ainsi que de raideur de la nuque. Depuis quelques jours il est enrhumé et décrit une douleur à l'oreille droite pour laquelle il n'a pas consulté. Au status, le tympan droit est humide et dédifférencié. Vous faites une ponction lombaire qui montre un liquide trouble.

Quel est le germe le plus probable d'être responsable de ce tableau clinique:

- A. Staphylococcus aureus
- B. Haemophilus influenza
- C. Mycoplasma pneumoniae
- D. Pseudomonas aeruginosa
- E. Streptococcus pneumoniae

Réponse: E [Sûre] Doute sur HiB (selon AMBOSS mais le plus probable est pneumocoque)

Q90: [Question complète] (ANCRAGE)

Une patiente de 82 ans, connue pour une consommation chronique d'alcool, se présente aux urgences en raison d'une légère dyspnée d'une fatigue, un ictère, un angiome stellaire et un érythème palmaire. Au status, vous remarquez un abdomen distendu mais souple sans douleurs à la palpation, la rate est palpable 5 cm sous le rebord costal. Au Labo, vous avez:

HB 102g/l

MCV 82 Thrombocytes 105 G/l ASAT 53

Alat 49

Bili 45

GGT 300

Albumine 29

INR 1.7

Quelle est l'étiologie la plus vraisemblable de la thrombocytopénie?

- A. Hypersplénisme
- B. Carence en folates
- C. Aplasie médullaire
- D. Hémorragie gastro-intestinale
- E. Leucémie myéloïde aigüe

Réponse : A [Sûre]

Q91: [Question complète]

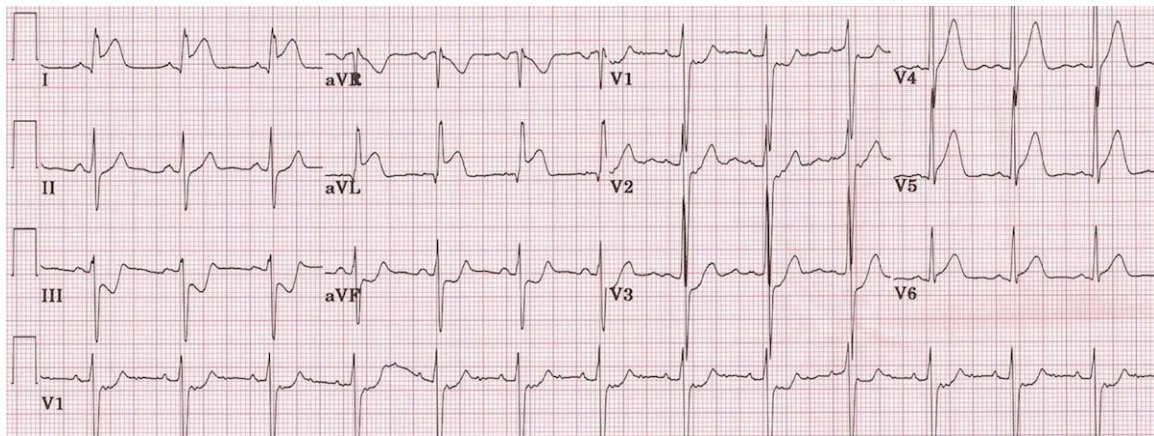
Patient qui présente des douleurs thoraciques soudaines accompagné d'une dyspnée depuis une demi-heure. Les secours arrivent sur place et réalisent leur première évaluation:

A: Voies aériennes libres et perméable

B: respiration spontanée et régulière. Fréquence respiratoire à 18/min, SpO2 à 96% à AA

C: FC régulière à 90 bpm et TA à 140/95

On réalise un ECG ci dessous:



Laquelle des mesures suivantes et la plus adaptée pour la prise en charge:

- A. Kétamine
- B. Ceftriaxone
- C. Acide acétylsalicylique
- D. Adrénaline
- E. Furosémide

Réponse: C [Sûre] → STEMI du territoire latéral gauche

Q92: [Question incomplète] (ANCRAGE)

Une jeune femme se présente en gynécologie. Elle n'est pas enceinte et n'aurait apparemment pas fait toutes les vaccinations recommandées. Elle n'est justement pas sûre de son statut vaccinal ROR. Quelle serait la chose à faire ?

- A. Lui donner une dose du vaccin
- B. Check ses sérologies
- C. Vacciner une fois puis regarder les sérologies et regarder en fonction pour la deuxième dose
- D. Vacciner avec deux doses à un mois d'écart

Réponse D [Sûre]

Q93: [Question complète/incomplète]

Patiente de 72 ans consulte aux urgences suite à une chute avec PC alors qu'elle était debout. Notions de vertiges avant la PC. Sa fille était présente et dit qu'elle sa mère a repris connaissance directement après quelques secondes, sans fatigue. Il n'y a pas eu de secousses pendant la PC. Elle a présenté une gastro-entérite la semaine dernière avec diarrhées. Elle est traitée par metformine, IEC, torasémide. Quelle origine :

- A. Epilepsie
- B. Syncope psychogène
- C. Syncope
- D. AVC
- E. Hypoglycémie

Réponse: C [Sûre]

Q94: [Question complète]

Patient de 23 ans consulte aux urgences pour des crampes abdominales. Elle présente des épisodes d'urgences défécatoires. Elle a observé du sang dans ses selles depuis 5 semaines. Les douleurs sont transitoirement soulagées lors de la défécation. Récemment elle n'a pas fait de voyage. Pas d'antécédent de prise d'antibiotique lors des 2 derniers mois. Pas de personne malade dans l'entourage. A l'examen sanguin on retrouve des leucocytes à 12,3 et une CRP à 13. Quel est le diagnostic :

- A. Adénome rectal
- B. Colite pseudo membraneuse
- C. Infection à cholerae vibrians
- D. Colite ulcéraire distale

Réponse : D [Sûre]

Q95:[Question incomplète]

Patient de 40 ans, consulte pour une asthénie avec perte de poids je crois. Diagnostic récent de VIH avec suite de prise en charge organisée en maladie infectieuse. Se plaint de dyspnée nouvelle à l'effort avec une toux sèche, EF.

A l'examen clinique: Auscultation pulmonaire dégueux en base gauche. ADP inguinales bilatérales.

Et on avait un CT

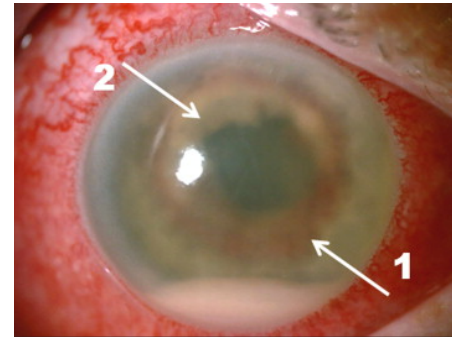
- A. Pneumocystis a jirovecii
- B. Tuberculose
- C. Pneumonie bactérienne
- D. Pneumonie virale

Réponse: A [Sûre]



Q96: [Question complète]

Patient opéré il y a 3 jours de la cataracte. Il revient consulter en raison de douleurs oculaires, d'un oeil rouge et d'une perte de vision. Lors de l'inspection de l'oeil, vous visualisez ça :



Quel est le diagnostic ?

- A. Kératite herpétique
- B. Subluxation de la lentille nouvellement implantée
- C. Endophtalmite
- D. Glaucome aigu
- E. Paraphymosis

Réponse : C [Sûre] → hypopion, fréquent en post-opératoire de la cataracte

Q97: [Question incomplète]

Mère qui consulte avec son bébé de 2 mois car il pleure pendant 2h le soir après les repas en repliant les jambes sur son ventre.. Il se calme facilement lorsqu'on le prend dans les bras. Les selles sont jaunes et moulées. Il se calme après le rot. Croissance ok. Que faire pour la suite de PEC?

- A. US abdominal
- B. Ne rien faire / rassurer la mère
- C. Changer de lait pour un lait HA
- D. Transit barythé
- E. Ph-métrie

Réponse: B [Sûre] → coliques du NN

Q98: [Question complète]

Question type A: Patient de X an qui consulte pour une hypoesthésie de la face palmaire du doigt V et doigt IV de la main droite. Il raconte que ces symptômes se sont péjorés depuis qu'il fait du vélo. Il mentionne un déficit de flexion de D4 et D5. À l'examen clinique vous observez une hypotrophie du muscle hypothénar ainsi qu'un déficit de l'adduction du pouce. Pas de trouble vasculaire. Quelle structure anatomique est le plus susceptible d'être atteinte?

- A. Nerf Radial
- B. Nerf ulnaire
- C. Nerf Médian
- D. Racine C6
- E. Racine C7

Réponse: B [Sûre]

Q99: [Question incomplète]

Femme de 43 ans primipares sans atcd, 22e SG, consulte son généraliste. Douleurs épigastriques avec état de malaise. Labo :

HB 93 g/dl

Leucos normaux

Thrombocytes 45

ASAT 256

ALAT 267

LDH 1430

Bilirubine 45 30% indirecte

- A. Cholecystite aigue
- B. Diverticulite
- C. Syndrome de HELLP
- D. Appendicite
- E. Cholestase gravidique

Réponse: C [Sûre]

Q100: [Question complète]

Homme de 77 ans qui consulte pour une fatigue. Depuis quelques mois, il souffre d'une baisse de son état général et d'une aggravation de ses troubles cognitifs. Lors de la consultation, il admet une consommation irrégulière de somnifères. Des doutes persistent quant à sa capacité de conduite. Cependant, il refuse d'en parler.

Quelle est l'attitude la plus correcte au niveau médico-légal?

- A. Investiguer uniquement les troubles somatiques
- B. Demander à sa femme de d'avertir la police
- C. Demander au médecin cantonal d'être délié du secret médical
- D. Avertir l'autorité cantonale responsable de la sécurité routière
- E. Avertir son assurance voiture

Réponse : D [Sûre]

Q101: [Question incomplète, débattue]

Un adolescent de 16 ans consulte avec sa mère pour son surpoids. Il avait déjà consulté il y a 2 ans avec un bilan réalisé qui était revenu dans la norme (*je sais plus comment c'était dit mais j'avais interprété ça en mode pas d'arguments pour une obésité endogène*). Depuis il pratique une activité physique régulière et une alimentation équilibrée selon sa mère mais pas de modification significative du poids. Contexte de dégradation de l'image corporelle chez le patient.

On a une courbe de croissance avec une taille au P50 et un poids au P97 depuis 2 ans et une courbe de BMI autour de 29 aussi depuis 2 ans. Avant ça, la croissance était harmonieuse autour du P50. Dans l'enfance il était plutôt dans un poids et un BMI normal/bas avec augmentation progressive au début de l'adolescence.

Quelle est la prise en charge la plus appropriée

- A. Examen génétique
- B. Thérapie nutritionnelle
- C. Rechercher un TCA
- D. Pratiquer plus d'activité physique
- E. L'envoyer dans un camp pour enfant obèse (oui vraiment)

Réponse : [Débattue] B, selon moi, mais certains ont mis A +3 ou C +1 (rechercher Binge eating, peut-être il ne mange rien avec parents mais +++ en cachette ou sans s'en rendre compte).

Vu qu'un bilan avait déjà été fait il y a deux ans (sans préciser ce qui était inclu) je penche pas pour le cause génétique (en plus il était dans des valeurs normales dans l'enfance), et j'ai aucun argument pour les TCA non plus...

Q102: [Question incomplète, débattue]

Femme qui vient consulter chez son MT pour humeur déprimée. Elle a perdu sa mère il y a 2 mois à la suite d'une maladie qui a duré de nombreux mois Elle dort mal. Elle parle puis tout d'un coup regarde dehors pendant quelques minutes et ne parle plus (décrit comme des absences) avec idées noires non scénarisées. Elle décrit également des idées de persécution.

Que faites-vous?

- A. Prescrire un anxiolytique
- B. Consultation psychiatrique le jour-même
- C. Consultation chez un psychologue dans 3 jours
- D. Prescrire un anxiolytique + antidépresseur et la revoir
- E. La revoir dans 4 semaines

Réponse : C - idées suicidaires non scénarisées donc semi-urgence. [débattue], B +5 Les idées intrusives étaient constantes tjr la? Surtout qu'elle a besoins d'un psychiatre + que d'un psychologue?

Q103: [Question complète]

Patient de 38 ans, CEO d'une entreprise, vous consulte pour des insomnies. Il dit prendre plus de deux heures à s'endormir, et se réveiller 2-3x pendant la nuit. Il raconte être très stressé par son travail, il a perdu confiance en lui, il a également beaucoup de mal à se concentrer. Sa famille se plaint qu'il n'arrive pas à se reposer pendant ses jours de congé.

De quoi souffre ce patient :

- A. Insomnie primaire
- B. Anxiété généralisée
- C. SAOS
- D. Dépression modérée avec épuisement professionnel
- E. TDAH

Réponse : D [Sûre]

Q104: [Question incomplète]

Une femme de 48 ans en BSH a fait beaucoup de sport ces derniers jours. Elle se plaint de douleurs thoraciques sans irradiation, pas de nausées ni vomissements. Paramètres vitaux stables (pas sûr que c'était mentionné, mais le statut était calme/stable). Pas de douleurs au repos, les douleurs sont reproductibles à la palpation. Nous effectuons un ECG normal. Quel est la prochaine étape diagnostique ?

- A. Radiographie thorax
- B. Doser les troponines
- C. Test d'effort
- D. CT angio
- E. Aucun autre examen nécessaire

Réponse : E [Sûre]

Q105: **K'** [Question complète]

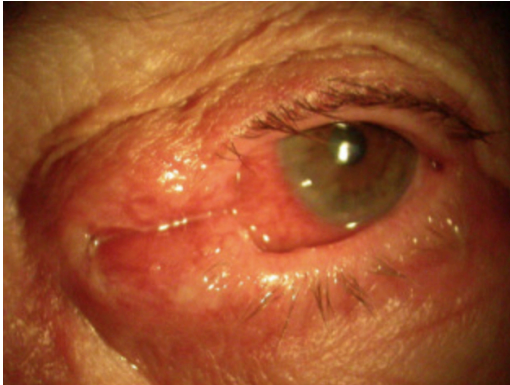
Un patient de 24 ans consulte les urgences ophtalmologiques pour des douleurs oculaires suite à la réception d'une balle de Squash dans l'œil droit. Quelle lésion serait expliquée par la clinique ?

- A. Druses
- B. Hyphéma
- C. Subluxation du cristallin
- D. Œdème de la rétine

Réponse : -/+ / +/+

Q106: **K'** [Question incomplète]

Photo d'un œil dégueulasse (dacryocystite avec écoulement purulent). Quelles sont les complications possibles ?



- A. Abscess périororbitaires
- B. Cellulite orbitaire
- C. Sténose permanente du canal lacrymal
- D. Thrombose du sinus caverneux

Réponse : +/+/+/+ [Sûre] → vu avec le Chat qui a pété

Q107: **K'** [Question complète]

Une mère vous demande des infos sur le vaccin HPV concernant sa fille :

- A. Le vaccin diminue les dysplasies du col de l'utérus
- B. Le vaccin diminue les dysplasies de la vulve et du vagin
- C. Le vaccin est recommandé pour toutes les filles de 11-14 ans
- D. Permet un retard de dépistage du cancer du col chez les personnes vaccinées

Réponse: +/+/+/- [Sûre]

Q108: **K'** [Question complète, débattue]

Dans le cadre de votre activité dans votre cabinet, vous effectuez pour une entreprise pharmaceutique une étude sous contrat.

Qu'est ce qui est correct:

- A. Vous devez disposer d'un certificat de bonne pratique à jour
- B. Vous devez suivre une formation sur le protocole de l'étude
- C. Vous recrutez les patients en fonction des critères d'inclusions
- D. Les patients inclus peuvent quitter l'étude à tout moment

Réponse: -/+ /+ /+ ou +/+ /+ /+ [Débattue] je suis sûre que A est juste, car si c'est ton cabinet tu es Principal Investigator de ton site d'étude et c'est demandé que cette personne ait un certificat de bonnes pratiques dans l'éthique de la recherche

Q109: **K'** [Question complète, débattue]

Patiente d'une 30aine avec AVP, sa voiture tombe dans une rivière et la patiente arrive à s'en sortir seule après 5 minutes. Retrouvée toute mouillée au bord de la rivière par les urgences, elle n'a pas de douleurs, pas de lésions externes. Sa température est à 33.1°C en tympanique. TA ~105/65, normocarde.

- A. Perfusion intraveineuse à la température corporelle
- B. Hémodialyse avec dialysats réchauffés
- C. Boissons chaudes
- D. Couverture réchauffante

Réponse: -/- /+ /+ [Débattue] → hypothermie légère (>32 C, donc réchauffement passif seulement) -/- /- /+ (+3) Selon multiples guidelines, si la personne est alerte et aucune difficulté à déglutir, boissons chaudes recommandées.

Q110: **K'** [Question incomplète]

Quelle est la symptomatologie corrélée à l'image scannographique ?

- A. Démarche instable
- B. Rigidité
- C. Incontinence urinaire
- D. Raideur de nuque

Réponse: +/- /+ /- [Sûre]



Q111: Menu déroulant [Question complète/incomplète]

Un homme de 59 ans, connu pour un syndrome métabolique, présente une douleur, rougeur et tuméfaction au dos du pied depuis 5 jours, sensible à la palpation. La douleur est présente au repos et la nuit. Il est afébrile. Au status, le pied présente un érythème, est gonflé et peau tendue dorsalement et la palpation est très douloureuse. Pas de lésions de peau, pas

de trauma. Quel est le diagnostic le plus probable?



Réponse: Goutte [Sûre] → c'était exactement la même photo, et celle-ci correspond à une photo de goutte trouvée sur internet

Q112: Menu déroulant [Question complète]

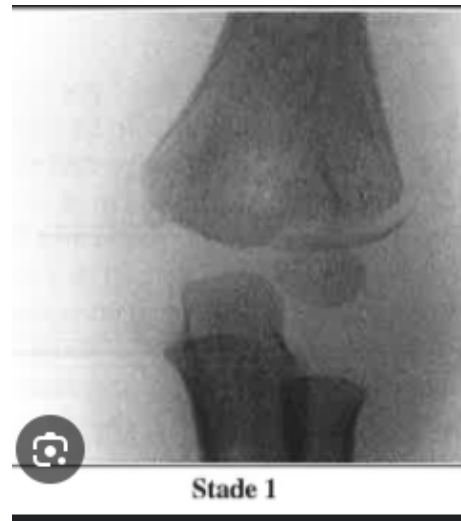
Homme de 34 ans, travaillant dans les canalisations, vient aux urgences pour une "jaunisse". Il y a une semaine, il a présenté une forte fièvre et des douleurs musculaires. La fièvre est tombée il y a 4 jours. Sa femme trouve qu'il a les yeux jaunes depuis hier. Il a une hyperbilirubinémie et les transaminases sont légèrement augmentées. Le patient est dans un état général diminué. Peu après son admission il est transféré aux SI pour une atteinte des poumons, du foie et des reins (vraiment dit comme ça). L'hypothèse diagnostique basée sur la clinique est confirmée par un test sérologique de micro-agglutination.

Quel est le diagnostic ?

Réponse : Leptospirose (la majorité on l'avait pas mdr)

Q113.1 : Questions suivies [Question complète]

Un garçon de 7 ans est emmené aux urgences par sa mère suite à une chute en skateboard sur le poignet gauche avec le bras en extension avec une douleur immédiate. Il se plaint depuis de douleurs au niveau du coude qui est tuméfié. On réalise une radiographie du coude gauche.



(C'était une sorte de mix entre ces deux Rx, y avait aussi une Rx de profil) On voyait bien la ligne de fracture sur le condyle latéral, et la tête radiale était luxée) Il n'y avait pas de fat-pad visible.



Qu'est-ce qui correspond le plus à cette radiographie ?

- A. Sub-luxation de la tête radiale
- B. Entorse du coude
- C. Fracture supracondylienne
- D. Fracture du condyle latéral
- E. Fracture du radius

Réponse: D [Sûre]

Q113.2 : **Questions suivies** [Question complète]

La Rx confirme une fracture du condyle latéral. Qu'est-ce qui doit être testé en priorité ?

- A. Pronation de l'avant-bras
- B. Sensibilité du territoire du nerf axillaire
- C. Crépitement à la palpation de l'articulation
- D. Pouls huméral
- E. Extension du poignet

Réponse : E +5 n.radial [Sûre/Débatue] moi A perso / je pense pas qu'il faille tester la pronation sur un coude fracturé, surtout que tu peux tester tous les nerfs distalement

Q114.1 : **Questions suivies** [Question complète]

Femme de 35 sans antécédents médicaux ni chirurgicaux. Cycle de 28 jours réguliers, dernières règles normales il y a 4 jours. Présente une douleur en fosse iliaque gauche. Pas de contraception hormonale. Elle est apyrétique, stable hémodynamiquement. L'abdomen est souple, mais une douleur à la palpation profonde de la fosse iliaque gauche est notée, sans défense ni contracture. Un toucher vaginal met en évidence une masse de la taille d'une orange. Lors de la mobilisation du col, pas de mouvement de la masse associée.

Quelle est votre suspicion diagnostique ?

- A. GEU
- B. Appendicite
- C. Kyste annexiel gauche
- D. Endométriose
- E. Annexite

Réponse: C [Sûre]

Q114.2 Questions suivies [Question complète]

Vous soupçonnez un kyste annexiel gauche.

Quel examen complémentaire permettra d'étayer votre diagnostic ?

- A. US abdominal
- B. US endovaginal
- C. CT abdomino-pelvien
- D. IRM pelvien
- E. Hysterosalpingographie

Réponse : B [Sûre]

Q114.3 Questions suivies [Question complète]

Une échographie endovaginale confirme la présence d'un kyste de 9cm, d'aspect évocateur pour un kyste dermoïde. Il n'y a pas de liquide libre dans le pelvis.

Quelle est la prise en charge recommandée ?

- A. Traitement par contraception oestroprogestative et contrôle à 3 mois du kyste par échographie
- B. Ponction du kyste sous contrôle radiologique
- C. Laparoscopie exploratrice avec kystectomie
- D. Laparoscopie exploratrice avec annexectomie bilatérale
- E. Traitement par analogues GnRH et contrôle à 3 mois du kyste par échographie

Réponse : C [Sûre]

Q115.1: Questions suivies [Question complète]

Femme de 24 ans, qui se présente à votre consultation pour des douleurs à la mictions, une envie permanente d'uriner et une odeur nauséabonde des urines depuis deux jours. Sur les conseils d'une amie, elle a augmenté son hydratation et pris des antalgiques mais ça ne va pas mieux. L'examen clinique est normal. La patiente n'a pas d'antécédent médico-chirurgical.

Quelle est la suite de la prise en charge?

- A. CT scan de l'abdomen
- B. US des voies urinaires et des reins
- C. Culture d'urines
- D. Aucun autre examen n'est nécessaire

Réponse: D [Sûre], bâtard psk tu vois qu'il y a 2 questions après donc tu te dis on va quand même faire qqch

115.2: Questions suivies [Question complète]

Aucun autre examen n'est indiqué. Quel est le germe le plus courant de ce type d'infection ?

- A. E. Coli
- B. Staphylocoque saprophyticus
- C. Proteus Mirbailis
- D. Klebsiella

Réponse : A [Sûre]

115.3: C'est un E. Coli. Quel serait le traitement ?

- A. Fosfomycine
- B. Nitrofurantoïne
- C. Co-amoxicilline
- D. Gentamycine
- E. Fluconazole

Réponse : B [Sûre]